КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА АЛЧЕБА (ALCEBA)

Торговое название препарата: Алчеба
Действующее вещество (МНН): Мемантина гидрохлорид
Лекарственная форма: Таблетки 10мг и Капли для приема внутрь
Состав:
1 г капель для приема внутрь содержит
Активное вещество:
мемантина гидрохлорид 10 мг
Код АТХ: N06DX01
Фармакологические свойства
Мемантин - потенциалзависимый , средней аффинности неконкурентный антагонист N-метил-D-аспартат (NMDA)-рецепторов, оказывает модулирующее действие на глутаматергическую систему. Мемантин представляет собой обратимый блокатор постсинаптических NMDA-рецепторов глутамата. Применение мемантина повышает порог генерации потенциала возбуждения постсинаптической мембраны, но не блокирует глутаматэргический синапс полностью. Известно, что при болезни Альцгеймера, острой и хронической ишемии головного мозга и других церебральных заболеваниях с картиной тяжелых когнитивных нарушений активность глутаматергической системы повышается и в синаптическую щель выделяется больше медиатора и глутамат накапливается в цитотоксических концентрациях, запуская процесс эксайтотоксичности ,что приводит к гибели нейронов. Таким образом, применение мемантина при когнитивных нарушениях различной этиологии способствует нормализации паттерна глутаматергической передачи, что лежит в основе нейропротекторного и положительного симптоматического эффекта данного препарата. Мемантин регулирует ионный транспорт, блокирует кальциевые каналы, нормализует мембранный потенциал, улучшает процесс передачи нервного импульса, улучшает когнитивные процессы, память, концентрацию , внимание и способность к обучению, повышает повседневную активность, уменьшает утомляемость и симптомы депрессии. Так же мемантин блокирует глутаматные рецепторы черной субстанции, тем самым снижая чрезмерное стимулирующее влияние кортикальных глутаматных нейронов на неостреатум , развивающееся на фоне недостаточного выделения дофамина. Оказывает нейромодулирующее действие . Помимо действия на ЦНС мемантин влияет на эфферентную иннервацию. В большей степени влияет на скованность (ригидность и брадикинезию), уменьшает спастичность , вызванную заболеваниями и повреждениями мозга.
Фармакокинетика
Всасывание: После приема внутрь быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация достигается в течение 3-8 часов. При нормальной функции почек кумуляции мемантина не отмечено.
Распределение: ежедневные дозы в 20 мг в сутки ведут к стабильной концентрации мемантина в плазме 70-150 нг/мл (0,5-1 мкмоль) с большими межличностными вариациями. При ежедневных дозах от 5 до 30 мг было рассчитано среднее соотношение цереброспинальной жидкости (CSF) /

сыворотки 0,52. Объем распределения составляет около 10 л/кг. Около 45% мемантина связано с белками плазмы.
Метаболизм: около 80% мемантина выводится в неизмененном виде. При экспериментах *in vitro* метаболизма, осуществляемого цитохромом Р450, выявлено не было. Метаболиты не обладают собственной фармакологической активностью.
Выведение: Выводится из организма моноэкспоненциально, с периодом полувыведения терминальной фазы 60-100 часов. Выводится с мочой. При щелочной реакции мочи выведение замедляется.

Показания к применению

- Деменция альцгеймеровского типа, сосудистая деменция, смешанная деменция всех степеней тяжести.
- Нарушение функции ЦНС легкой и средней степени тяжести (когнитивные нарушения , снижение памяти, способности к концентрации внимания и способности к обучению, потеря интереса к деятельности , быстрая умственная утомляемость , ограничение способности обслуживать себя).
- Церебральный и спинальный спастический синдром, в том числе вследствие черепно-мозговой травмы, рассеянного склероза, инсульта, постинсультная афазия, болезнь Паркинсона, болезнь Пика , хорея Хенгтинтона.
- **В детской практике**
- Нарушения речи различного генеза (олигофазия , брадилалия , заикание др.).
- Когнитивные нарушения (гнозис , праксис , память, внимание и др.) и поведенческие нарушения, социальная дезадаптация.
- Синдром гиперактивности с дефицитом внимания.
- В комплексном лечении энуреза и РДА.

Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату, выраженные нарушения функции почек, беременность, грудное вскармливание.
С осторожностью
С осторожностью назначают больным тиреотоксикозом, эпилепсией; предрасположенностью к развитию судорог, одновременное применение антагонистов NMDA-рецепторов (амантадин, кетамин, декстрометорфан), наличие факторов, повышающих pH мочи (резкая смена диеты, например, переход на вегетарианство, обильный прием щелочных буферных растворов), тяжелые инфекции мочевыводящих путей (вызванные *Proteus bacteria),* инфаркт миокарда (в анамнезе), сердечная недостаточность III-IV класс (по классификации NYHA), неконтролируемая артериальная гипертензия, почечная недостаточность, печеночная недостаточность.

Способ применения и дозы
Препарат следует принимать внутрь один раз в день и всегда в одно и тоже время желательно после еды.
Режим дозирования устанавливается индивидуально. Начинать лечение рекомендуют с назначения минимально эффективных доз.

Переносимость и дозу препарата следует регулярно оценивать, преимущественно в течение трех месяцев после начала лечения. Затем следует регулярно оценивать клиническую эффективность лекарственного препарата и переносимость терапии в соответствии с действующими клиническими рекомендациями.
Максимальная суточная доза мемантина составляет 40 мг.
Взрослым:
Рекомендуемая доза составляет 5 мг в день, что составляет первые 4 недели лечения. Максимальная суточная доза составляет 40 мг в день. Чтобы снизить риск нежелательных эффектов, поддерживающая доза достигается повышением титрования до 5 мг в неделю в течение первых 3 недель следующим образом:

- в течение 1-й недели терапии (дни 1-7) в дозе 5 мг/сут в течение 7 дней
- в течение 2-й недели (дни 8-14) - в дозе 10 мг/сут в течение 7 дней
- в течение 3-й недели (дни 15-21) - по 15 мг/сут- в течение 7 дней
- Начиная с 4-й недели - по 20 мг/сут

Рекомендуемая поддерживающая доза составляет 20 мг в день
Пациенты пожилого возраста
На основании клинических исследований рекомендуемая доза для пациентов старше 65 лет составляет 20 мг в день.
Детям старше года дозу подбирают из расчета 500мкг/кг/сут. С титрованием дозы (шаг титрования 2,5 мкг/сут через 1 неделю),при этом курс фармакотерапии составляет минимум 1месяц постоянного приема в утренние часы после еды.
Максимальная суточная доза у детей составляет 20мг/сут (40 капель). Чтобы снизить риск нежелательных эффектов, поддерживающая доза достигается повышением титрования до 2,5 мг в неделю в течение первых 3 недель следующим образом:

- в течение 1-й недели терапии (дни 1-7) в дозе 2,5 мг/сут (5 капель) в течение 7 дней
- в течение 2-й недели (дни 8-14) - в дозе 5 мг/сут (10 капель) в течение 7 дней
- в течение 3-й недели (дни 15-21) - по 7,5 мг/сут (15 капель)- в течение 7 дней
- Начиная с 4-й недели - по 10 мг/сут (20 капель).
- Поддерживающая доза рассчитывается индивидуально

Передозировка
По результатам клинических исследований и пострегистрационного наблюдения получены лишь ограниченные данные по передозировке.
Симптомы
Относительно большая передозировка (200 мг и 105 мг/день в течение 3 дней соответственно) проявлялась только утомляемостью, слабостью и (или) диареей, либо симптомы отсутствовали. У пациентов с передозировкой <140 мг либо с неизвестной дозой наблюдались симптомы со стороны центральной нервной системы (спутанность сознания, гиперсомния, сонливость, вестибулярное головокружение, ажитация, агрессия, галлюцинации, нарушение походки) и (или) желудочно-кишечного тракта (рвота и диарея).

В наиболее тяжелом случае при приеме 2000 мг мемантина пациент выжил, однако наблюдались нарушения со стороны центральной нервной системы: кома в течение 10 дней с последующей диплопией и ажитацией. Пациенту были назначены симптоматическое лечение и плазмаферез. Наступило выздоровление без необратимых последствий.
В другом зарегистрированном случае пациент также выжил и выздоровел. После приема 400 мг мемантина внутрь у него отмечались следующие нарушения со стороны центральной нервной системы: беспокойство, психоз, зрительные галлюцинации, склонность к судорожным реакциям, сонливость, ступор и потеря сознания.
Лечение
В случае передозировки проводят симптоматическое лечение. Специфического антидота от интоксикации или передозировки нет. Следует воспользоваться стандартными терапевтическими мероприятиями для удаления действующего вещества, например, промывание желудка, прием активированного угля (для предотвращения потенциальной рециркуляции в кишечнике и печени), симптоматическая терапия. Устранению передозировки мемантином может способствовать подкисление мочи, форсированный диурез.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При одновременном применении с барбитуратами, нейролептиками, антихолинергическими средствами действие последних может усиливаться.
При одновременном применении с барбитуратами, нейролептиками действие последних может уменьшаться, при применении с нейролептиками позволяет уменьшить проявления нейролептического синдрома.
При совместном применении может изменить (усилить или уменьшить) действие дантролена или баклофена, поэтому дозы препаратов следует подбирать индивидуально.
Следует избегать одновременного назначения с амантадином, кетамином, фенитоином и декстрометорфаном из-за повышения риска развития психоза.
Возможно повышение в плазме уровней циметидина, ранитидина, прокаинамида, хинидина, хинина и никотина при одновременном приеме с мемантином.
Возможно снижение концентрации гидрохлоротиазида при одновременном приеме с мемантином. Мемантин может увеличивать экскрецию гидрохлоротиазида.
Возможно снижение МНО (международное нормализованное отношение) у пациентов, принимающих пероральные антикоагулянты (варфарин).
Одновременное применение с антидепрессантами, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и ингибиторами моноаминоксидазы требует тщательного наблюдения за пациентами.

Особые указания
Наличие у пациента факторов, влияющих на повышение pH мочи (резкие изменения в питании, например, переход с рациона, включающего продукты животного происхождения, к вегетарианской диете, или интенсивное употребление щелочных желудочных буферов), а также почечный канальцевый ацидоз или тяжелые инфекции мочевыводящих путей, вызванные *Proteus spp.,* требуют тщательного наблюдения за состоянием пациента.

Из большинства клинических исследований пациенты с инфарктом миокарда в анамнезе, декомпенсированной хронической сердечной недостаточностью (III-IV функциональный класс по классификации NYHA), или неконтролируемой артериальной гипертензией были исключены. Поэтому данные о применении мемантина у таких пациентов ограничены, прием препарата должен осуществляться под тщательным наблюдением врача.
Препарат содержит сорбитол. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы не должны принимать это лекарство.
Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами.
У пациентов с болезнью Альцгеймера на стадии умеренной и тяжелой деменции обычно нарушена способность к вождению автотранспорта и управлению сложными механизмами. Кроме того, мемантин может вызывать изменение скорости реакции, поэтому у пациентов, получающих лечение в амбулаторных условиях, следует соблюдать особую осторожность при вождении автотранспорта или управлении механизмами.

Форма выпуска
Капли для приема внутрь, 10 мг/мл. и таблетки 10мг № 30
По 100 г во стеклянном флаконе янтарного цвета с крышкой дозатором.
1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку
Условия отпуска
По рецепту врача.
Владелец торговой лицензии
Helba Pharmaceuticals Inc. Co., Turkey
Производитель
Merkez Laboratory Pharmaceutical and Trade Co., Turkey